随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·再生障碍性贫血

（性感认识：骨髓造血衰竭）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

（1）病毒感染：肝炎病毒、微小病毒 B_{19} 等

（2）化学因素

①抗肿瘤药、苯：对骨髓的抑制与剂量相关

②氯霉素、磺胺：对骨髓的抑制与剂量无关，停药后再障不会继续发展 特异体质



（3）长期接触射线

二、骨髓造血衰竭

①“种子”缺陷——造血干祖细胞缺陷：骨髓 **CD34 细胞↓**（撒种子要三思）

②“土壤”不佳——造血微环境异常：骨髓 ttsx 脂肪化（干抽）抽不到骨髓液

③“虫子”出现——免疫异常：淋巴细胞比例增高（主要 **CD8 T 细胞↑**）、负调控因子（IL-2、TNF、IFN）↑

（不再爱过）CD8↑:再障、ITP、过敏性肺炎

三、临床表现和检查

1.**全血细胞减少**：贫血、感染、出血

①**血小板↓最明显**、在治疗时最难恢复 plt寿命最短

②贫血在晚期出现 RBC寿命长

2.**多无肝脾肿大**

注意：没有肝脾肿大此阴性表现很重要，可优先考虑再障、ITP（可继发缺铁贫）、急性风湿热（不再 iphone）

3.**Ret＜1%（重症＜0.5%）**、**正细胞**性贫血、中性粒细胞碱性磷酸酶 **NAP↑**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

VS ALP是血液内的碱性磷酸酶 无间道

成骨性病变e.g骨肉瘤、前列腺癌成骨性骨转移

无性细胞瘤

造成胆道梗阻如肝癌

《诊断学》：NAP 主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞

①**NAP↓：急粒、慢粒、SLE、PNH、病毒性感染**（正常或↓）莉莉睡病毒 莉莉是女的

好发女性

造不出新的,只留下成熟的

②NAP↑：**再障**（再长高）、**急淋**、**慢粒急性变**、细菌性感染→类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

急性造血功能停滞

↓

Hb↓,Plt↓,WBC↑(抗感染)

其他部位都低下,只有胸骨局部增生活跃

4.确诊：**髂骨、胸骨等多部位骨髓穿刺或穿刺+活检**

（注意：不要选单独的骨髓活检）选骨髓穿刺/骨髓穿刺+活检

①骨髓增生**低下**、**三系↓尤其巨核系**（**全片未见巨核细胞**强调数量）、骨髓小粒空虚 巨核系本身为弱势群体

非造血细胞

②**脂肪细胞和淋巴细胞↑**（**CD4/CD8↓**）骨髓脂肪化、免疫“虫子”

③有时胸骨可见局部灶性增生活跃、但**巨核细胞↓**

人体向心性造血

再障:
淋巴结无肿大
血淋巴细胞↑

WBC:
N: 中性粒细胞
L: 淋巴细胞

正常情况下,中性粒细胞是白细胞里面最多的,但如果血常规内淋巴细胞比例多了,有可能是再障